

SCANNER & IRM NORMANDIE

Centre d'Imagerie Médicale
18 rue Jeanne d'Arc
76000 ROUEN
Résultats : imagerie-normandie.fr
Téléphone : 02.35.00.00.00

Nom : MOREL
Prénom : Éric
Date de naissance : 06/06/1969
Sexe : M

Rouen, le 24/04/2026
Dr Anne LEMAIRE
Médecin radiologue

SCANNER THORACO-ABDOMINO-PELVIER

Indication :

Traumatisme thoraco-abdominal fermé après accident de la voie publique. Douleurs de l'hypochondre gauche avec instabilité hémodynamique transitoire. Recherche de lésion viscérale ou hémorragique active.

Technique :

Acquisition volumique thoraco-abdomino-pelvienne réalisée après injection intraveineuse de produit de contraste iodé, avec acquisitions aux temps artériel et portal.
Reconstructions multiplanaires dans les plans axial, sagittal et coronal.
Analyse en fenêtres parenchymateuse, vasculaire, médiastinale, pulmonaire et osseuse.

Résultats :

À l'étage thoracique :

Contusion pulmonaire basale gauche sous forme de plages en verre dépoli postéro-basales.
Minime épanchement pleural gauche.
Pas de pneumothorax.
Pas d'épanchement péricardique.
Pas d'anomalie médiastinale évidente.
Pas d'argument pour lésion traumatique de l'aorte thoracique.

Foie et voies biliaires :

Foie de taille normale, de contours réguliers.
Pas de lésion traumatique hépatique identifiable.
Voies biliaires non dilatées.
Vésicule biliaire sans anomalie visible.

Rate :

Présence d'une fracture splénique profonde intéressant le pôle inférieur et le tiers moyen de la rate, mesurant environ 45 mm de profondeur.

Hématome sous-capsulaire splénique associé.

Présence d'une extravasation active de produit de contraste au temps artériel, persistante au temps portal, en regard du pôle inférieur splénique.

Aspect compatible avec un saignement actif.

Pancréas :

Pancréas de morphologie conservée.

Pas d'argument pour lésion pancréatique traumatique visible.

Surrénales :

Surrénales sans anomalie traumatique identifiable.

Reins et voies urinaires :

Reins de morphologie normale.

Pas de lésion traumatique rénale.

Pas de dilatation des cavités excrétrices.

Pas d'extravasation urinaire visible.

Tube digestif :

Pas d'épaississement pariétal digestif suspect.

Pas de pneumopéritoine.

Pas d'argument évident pour perforation digestive.

Cavité péritonéale :

Hémopéritoine de moyenne abondance, prédominant en péri-splénique, dans la gouttière pariéto-colique gauche et le pelvis.

Pas de collection organisée.

Vaisseaux :

Axes artériels abdominaux perméables.

Pas d'anévrisme.

Pas de dissection visible.

Aires ganglionnaires :

Pas d'adénopathie abdomino-pelvienne significative.

Structures osseuses :

Fractures non déplacées des arcs latéraux des 9^e et 10^e côtes gauches.

Pas de fracture vertébrale visible sur les coupes analysées.

Bassin sans fracture évidente.

Conclusion :

Lésion traumatique splénique sévère avec fracture profonde de la rate, hématome sous-capsulaire et **extravasation active de produit de contraste**, compatible avec un saignement actif.

Hémopéritoine de moyenne abondance.

Fractures costales gauches non déplacées associées, avec minime contusion pulmonaire basale gauche.

Absence d'argument pour lésion traumatique hépatique, rénale, pancréatique ou digestive visible.

Recommandations :

Prise en charge urgente en milieu spécialisé.

Avis chirurgical et radiologie interventionnelle en urgence.

Discussion d'une embolisation splénique en première intention selon stabilité hémodynamique.